Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

D T 0 9 8 8

CONSULTATION EN UROLOGIE ADULTE ET ENFANT

Attention : Consulter les alertes cliniques au verso et favoriser les protocoles de l'Accueil clinique (si disponibles) avant de remplir ce formulaire.

CRV

Raison de consultation		Échelle de priorité clinique : A : ≤3 jrs B : ≤10 jrs C : ≤28 jrs D : ≤3 mois E : ≤12 mois	
Lithiase	☒ Calcul urétéral *(Prérequis : prescrire A/C urine, créatinine, RX abdominale, uroscan)*	C	
	☐ Calcul rénal ou vésical asymptomatique *(Prérequis : rapport d'IM et prescrire A/C urine, créatinine et uroscan)*	D	
Infection	☐ Infection urinaire chez l'homme *(Prérequis : prescrire écho rénale et pelvienne, A/C urine)*	D	
	☐ Infections urinaires basses récidivantes documentées chez la femme (+ de 4 par année) *(Prérequis : A/C urine)*	E	
Dysfonction sexuelle	☐ Dysfonction érectile avec échec au traitement médical *(Prérequis : prescrire testostérone, glycémie, lipides, HbA1c)*	E	
	☐ Maladie de La Peyronie	E	
	☐ Hémospermie récidivante avec examen prostatique non suspect de malignité *(Prérequis : prescrire A/C urine, APS si > 40 ans)*	E	
Hématurie	☐ Hématurie macroscopique intermittente avec culture négative *(Prérequis : prescrire A/C urine, créatinine et pyéloscan)*	C	
	☐ Hématurie microscopique ≥ 2-5 GR/champ[1] *(Prérequis : prescrire A/C urine, écho abdominale pelvienne)*	D	
Suspicion de malignité	☐ Examen prostatique suspect (TR) *(Prérequis : prescrire APS)*	C	
	☐ APS élevé recontrôlé après 6 semaines *(Prérequis : APS x 2, A/C urine négative)*	C	
	☐ Masse vésicale (∗) *(Prérequis : rapport d'IM)*	C	
	☐ Masse rénale solide ou kyste rénal complexe *(Prérequis : créatinine, rapport d'IM et prescrire pyéloscan (si non réalisé))*	C	
	☐ Masse scrotale suspecte de néoplasie *(Prérequis : écho testiculaire)*	B	
Autres	☐ Masse scrotale bénigne : hydrocèle, varicocèle, spermatocèle *(Prérequis : écho testiculaire)*	E	
	☐ Hydronéphrose obstructive ou symptomatique *(Prérequis : rapport d'IM et prescrire créatinine, A/C urine)*	C	
	☐ Symptômes du bas appareil urinaire chez ♀ et ♂ (incontinence, vessie hyperactive, HBP avec échec de traitement) *(Prérequis : A/C urine et APS (si ♂))*	E	
	☐ Syndrome de **douleur** pelvienne chronique / orchialgie (incluant prostatite chronique, cystalgie) *(Prérequis : ITSS négatives, A/C urine)*	E	
	☐ Balanite récidivante/phimosis/vasectomie	E	

☐ **Autre raison de consultation non standardisée au formulaire ou modification d'une priorité clinique (Justification OBLIGATOIRE ci-dessous) :** — **Priorité clinique**

Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires

Calcul urétéral ☐ Gauche ☐ Droit

Si prérequis exigé(s)
- ☐ **Disponible(s) dans DSQ**
- ☐ **Annexé(s) à la présente demande**
- ☐ **Prescrit(s)**

Besoins spéciaux :

Identification du médecin référent et du point de service

Étampe

Nom du médecin référent			Nº de permis
Ind. Rég. Nº de téléphone Nº de poste		Ind. Rég. Nº de télécopieur Nº de poste	
Nom du point de service	Urgence HCSL		
Signature			Date (année, mois, jour)

Médecin de famille : ☐ **Idem au médecin référent** ☐ **Usager sans médecin de famille**

Nom du médecin de famille

Référence nominative (si requis)

Légende :

[1] Définition de l'hématurie microscopique significative :
Présence de plus de 2 GR/champ lors de 2 analyses par microscope après une certaine période sans exercice, sans menstruation, sans activité sexuelle et sans exploration instrumentale des voies urinaires.

Réf. : Guide de Pratique de l'Association Canadienne d'urologie, juin 2008.
American Urological Association guidelines, 2012.

(*) Masse vésicale : un pyéloscan serait souhaitable avant la consultation

N. B.

Si l'état de l'usager ne correspond pas à la priorité clinique établie ou s'il s'agit d'une situation imprécise, communiquer avec l'urologue de garde de votre région.

Alertes cliniques (liste non exhaustive)

Diriger ou garder l'usager à l'hôpital (urgence ou hospitalisation)

- **Hématurie macroscopique active (non infectieuse)**
- **Colique néphrétique non soulagée par la médication**
- **Hyperthermie d'origine urinaire**
- **Suspicion de torsion testiculaire**
- **Rétention urinaire aiguë**
- **Fracture du pénis ou priapisme**

RADIOLOGIE

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Québec

IMAGERIE MÉDICALE - Radiologie

Téléphone : 450-975-5530
Télécopieur clientèle interne (urgence et hospitalisée) : 450-975-5025
Télécopieur pour rendez-vous externe : 450-975-5040
Courriel pour rendez-vous externe :
requete.radiologie.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Date de l'examen : **Heure :** **Salle de Rx :**

NÉPHROTOXICITÉ	**ALLERGIE**
DFGe requise si présence d'un de ces facteurs de risque : ☐ ATCD maladie rénale (IRC, antécédent d'IRA, chirurgie rénale, protéinurie) **OU** ☐ Diabétique **DFGe valide dans les 7 jours pour usager de l'interne** DFGe : _____ Date : _____ / _____ / _____ ☐ Prise de sang pour DFGe demandée ☐ **Usager NON À RISQUE**	L'usager a-t-il une allergie connue à l'iode ? ☐ **OUI** ☐ **NON** **Si allergie à l'iode, se référer à l'OC-075**

EXAMEN DEMANDÉ : Plaque simple de l'abdomen

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES PERTINENTS : Suivi de calcul urétéral

AAAA MM JJ

Date : _____/_____/_____

_____ _____
Signature du médecin référent No de permis

Examen à faire le jour du suivi en urologie. Merci

Copie au Dr :

Code à barres - espace réservé à la radiologie

INFORMATION MÉDICALE SOMMAIRE

DT9098

À l'intention de : _____

Voici quelques renseignements concernant la personne ci-contre qui a été :

Vue à l'urgence ☒ Vue à la consultation externe ☐

Hospitalisée dans notre établissement ☐

Diagnostic principal et autres informations

Diagnostic principal: Colique néphrétique

Autres diagnostics et problèmes

Complications

Interventions et traitements

Recommandations à l'usager

Vous devez bien vous hydrater (viser ___ L par jour) et filtrer vos urines. Soulagez votre douleur avec la médication prescrite au besoin. Si la douleur est ne peut être soulagée, que vous faites de la fièvre ou que votre état se détériore, vous devez consulter immédiatement à l'urgence. Vous avez été référé au service d'urologie, ceux-ci vous contacteront pour vous donner un rendez-vous dans les prochaines semaines.

Médication prescrite

Incapacité

Visite de relance

Renseignements spéciaux

Date du rapport _____ (Année / Mois / Jour)

_____ Signature du médecin traitant